Sessió 4 · Teoria

⏱ 2h

Decisions informades

APARTAT 1

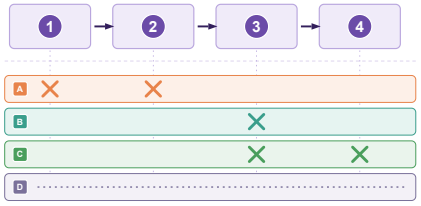
CRITIC: com es mira una afirmació que corre

Davant d'una afirmació no cal creure-se-la ni rebutjar-la de cop: es mira amb sis caselles. Consigna — quina és exactament l'afirmació? · Rol — qui ho diu i què hi guanya? · Idees — quin mecanisme proposa? En proposa cap? · Test — es podria comprovar, i com? · Informació — quines dades hi posa? Un cas que algú explica és una anècdota, i una anècdota no és una dada: sempre n'hi haurà alguna en cada direcció. · Conclusions — què en puc dir ara i què em falta saber? I una advertència sobre la IA: no és una font, és un programa que redacta. Pot donar-te una font que no diu el que ell diu, o que no existeix. Si te'n dóna una, ves a mirar-la.

APARTAT 2

La cadena de quatre baules i on talla cada família

Perquè hi hagi un embaràs han de passar quatre coses seguides: ① el cervell dóna l'ordre d'ovular (les hormones de la hipòfisi) → ② surt l'òvul de l'ovari → ③ els gàmetes es troben a la trompa → ④ l'embrió s'implanta a la paret de l'úter. Si en falla una, no hi ha embaràs. Per això cada família de mètodes talla la cadena en un punt diferent. Hormonals (píndola combinada, pegat transdèrmic, implant subcutani): aporten hormones que fan que no arribi l'ordre d'ovular → tallen a ①-②. Gairebé tots els mètodes fan més d'una cosa alhora —els hormonals també espesseixen el moc del coll de l'úter, que és una segona tanca a ③—, però la figura marca on talla principalment cada família, que és el que se't demanarà. De barrera (preservatiu extern i intern): impedeixen físicament que el semen entri en contacte amb la vagina → tallen a ③. DIU de coure: els ions de coure fan l'ambient tòxic per als espermatozoides —això és el principal— i, si tot i així hi ha fecundació, dificulten la implantació → talla a ③ i ④. I el mètode del calendari no talla res: no fa res al cos, només intenta endevinar quins dies són fèrtils.



Per quina raó només una família atura també els patògens

El preservatiu és l'únic que atura els fluids. I és als fluids que hi van els patògens — recorda «Defensors del cos»: una ITS (infecció de transmissió sexual) és una infecció, i el preservatiu hi fa de barrera, exactament igual que la pell. Els mètodes hormonals i el DIU actuen sobre el cicle o dins de l'úter: eviten l'embaràs, però no impedeixen que els fluids es trobin. Fixa-t'hi bé, perquè és l'error més freqüent: la pregunta no és com de bo és un mètode contra l'embaràs, és què atura. Per això el consell sanitari és la doble protecció: preservatiu més un altre mètode. I un matís que cal dir bé: el preservatiu redueix molt el risc d'ITS, però no el deixa a zero — hi ha infeccions que passen per contacte de pell que la funda no cobreix. Dir «protegeix» és correcte; dir «protegeix del tot», no.

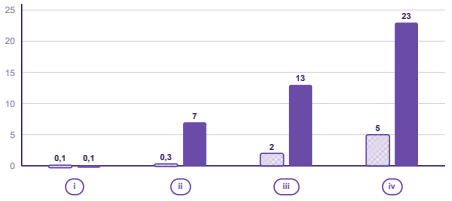
⚠ La confusió més estesa

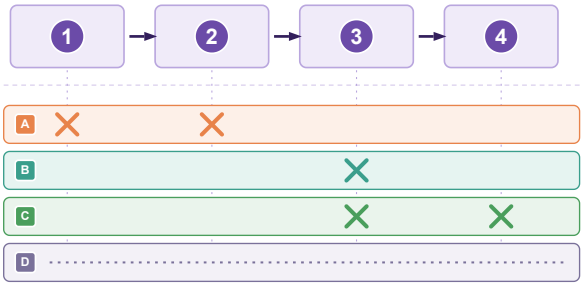
La píndola de l'endemà: què fa i què no fa

És un mètode d'emergència, no del dia a dia. El que fa és retardar o impedir l'ovulació: actua a les baules ①-②, com la resta d'hormonals. Per això com abans es pren, millor funciona. I una cosa que convé tenir clara perquè es confon molt sovint: no interromp un embaràs que ja està en marxa — si la implantació ja s'ha produït, no hi fa res.

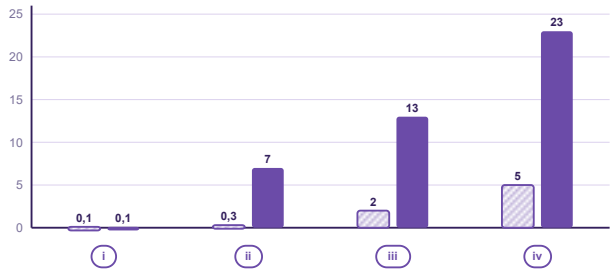
Ús perfecte i ús real: la distància entre les dues barres

Els mètodes es comparen amb una xifra: quantes persones de cada 100 tenen un embaràs no buscat en un any. I sempre se'n donen dues: la de l'ús perfecte (fent-ho sempre bé, sense cap badada) i la de l'ús real (com ho fa la gent de veritat). La segona mai no és millor —i sovint és molt pitjor—, però no en la mateixa mesura per a tots: n'hi ha que tenen les dues barres iguals. com més depèn el mètode de fer alguna cosa bé cada vegada (o cada dia), més s'allunyen les dues barres. Un implant, un cop col·locat, no depèn de res; una píndola depèn de cada dia; un preservatiu, de cada vegada. I el mètode del calendari depèn de cada cicle i a més cal encertar-lo — i a la sessió 2 ja vas veure, amb el cicle de la Laia, que el dia d'ovulació no és fix.





F1 — La cadena i on talla cada família
A dalt, les quatre baules amb marcadors ①-④. A baix, quatre files amb marcadors [A]-[D] en QUADRAT DE COLOR PLE (sistema diferent del rodó de les baules, perquè no es confonguin) i una ✗ sota cada baula que talla aquella família. La fila [D] no en té cap: aquest buit és el missatge, no un oblit. Cap paraula dins la imatge; les etiquetes són la llegenda de la fitxa.



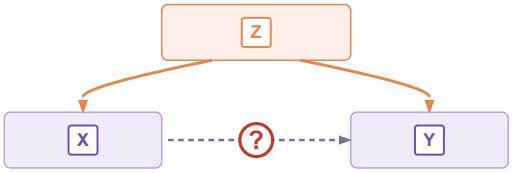
F2 — Ús perfecte contra ús real
Barres aparellades: embarassos no buscats per cada 100 persones en un any. Les dues barres del mateix mètode són del MATEIX color: el que es mira no és el color sinó l'emplenat — barra buida per dins = ús perfecte, barra plena = ús real. (i) implant · (ii) píndola · (iii) preservatiu · (iv) calendari · (v) cap mètode. Marcadors en NÚMERO ROMÀ dins d'un rètol arrodonit i buit, perquè a la mateixa pàgina F1 ja fa servir els ①-④ (baules) i els [A]-[D] (famílies): tres sistemes, tres significats. Xifres aproximades d'organismes de salut: serveixen per comparar mètodes, no per predir res d'una persona concreta.

APARTAT 3

La reflexió científica del dia

El mite, desmuntat

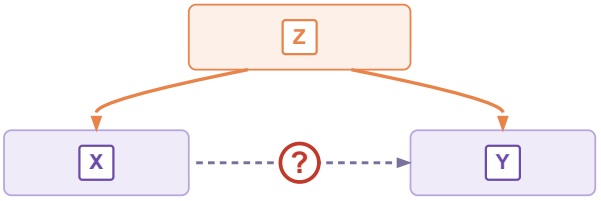
«Els anticonceptius et fan infèrtil per sempre.» Mirem-ho amb el que sabem. Què diu l'evidència: quan es deixa un anticonceptiu hormonal, el cicle es restableix, i els estudis que han seguit molta gent durant anys no troben que la fertilitat quedi tocada a llarg termini. I per quina raó l'afirmació no s'aguanta? Per tres coses alhora: (a) no proposa cap mecanisme — no diu què faria l'hormona per espatllar res; (b) no aporta cap dada, només casos que algú explica; i (c) confon una cosa que passa després amb una cosa que passa per culpa de. Si algú deixa la píndola als 34 anys i triga a tenir un embaràs, la píndola no és l'única cosa que ha canviat: també ha canviat l'edat. Això té nom: la tercera variable — una cosa que ha canviat alhora i que ningú no havia mirat, i que pot estar causant les altres dues. *(A la fitxa de la versió A hi ha una figura que ho dibuixa; a la resta n'hi ha prou amb aquest exemple.)* I sobre el «la píndola engreixa»: aquí no es discuteix el cos de ningú, es discuteix fins on arriba l'afirmació. Els efectes secundaris existeixen i són diferents en cada persona — per això això es parla amb un professional. El que no té base és el salt de «a algunes persones els passa» a «això li passa a tothom, sempre».



Tancament de la unitat

Com es decideix una cosa sobre el propi cos

No per por i no perquè una cosa estigui de moda. Es miren tres coses alhora: (1) què diu l'evidència; (2) quina és l'eficàcia real, no la del paper; i (3) el context de cada persona, que és diferent per a cadascú. I qui ho decideix és la persona, amb un professional sanitari — no una xarxa social i no una classe de biologia. El que fa la biologia és donar-te el mecanisme, perquè puguis entendre el que et diguin i preguntar bé. On es pot preguntar de debò: el CAP del barri (hi ha consulta jove, gratuïta i confidencial), el programa Salut i Escola del centre i Canal Salut, el web sanitari públic.



F3 — La tercera variable
Rètols en LLETRA dins d'un quadrat buit, que és el sistema que es fa servir per parlar de causes: X deixar l'anticonceptiu · Y trigar a tenir un embaràs · Z l'edat, que ha canviat alhora. La fletxa de punts entre X i Y, amb un ? vermell al mig, és la conclusió que la gent dóna per bona i que no està demostrada; les dues fletxes taronges són l'explicació alternativa (Z causa X i Y alhora). Només és a la fitxa de la versió A: a les altres dues versions la idea es treballa amb text, sense la figura.